

Cuestionario de integración comunitaria (Willer, Rosenthal, Kreutzer, Gordon, y Rempel, 1993)

El cuestionario de integración social o comunitaria (CIQ) se creó para evaluar el grado en que una persona que sufre un DCA es capaz de desempeñar adecuadamente su función en el hogar y en la sociedad.

No evalúa el estado emocional del paciente, se centra exclusivamente en su integración (evaluación funcional). Se organiza en tres subescalas: integración en el hogar, integración social y productividad.

La puntuación total se obtiene de la suma de las tres subescalas. A mayor puntuación mayor grado de integración.

El CIQ puede ser cumplimentado por el paciente o en entrevistas en persona o por teléfono.

Si el paciente con TCE no puede realizar la evaluación, un representante puede cumplimentar el cuestionario.

Medición de evaluación funcional (Hall, Hamilton, Gordon, y Zasler, 1993)

La medición de evaluación funcional (FIM+FAM) se creó específicamente para pacientes con lesión cerebral con la intención de mejorar la aplicabilidad de la FIM a dichos pacientes.

La escala de independencia funcional (**FIM**) evalúa la discapacidad física y cognitiva en cuanto a la carga asistencial, es decir, la puntuación obtenida en la FIM representa la carga de la asistencia de una persona. Se valoran seis aspectos funcionales: cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación y cognición social.

La **FAM** añade 12 apartados a los ya existentes en la escala FIM y evalúa las funciones cognitiva, comunicativa y psicosocial.

Los apartados de la FAM son los siguientes: tragar, meterse en el coche, acceso a la comunidad, leer, escribir, inteligibilidad del habla, estado emocional, adaptación a las limitaciones, empleabilidad, orientación, atención y conciencia de la seguridad.

La **FIM+FAM** consta de dos subescalas: funcionamiento físico y funcionamiento cognitivo/psicosocial. A mayor puntuación mayor grado de independencia.

El método de cumplimentación más frecuente es la observación directa.

Cuestionario de adaptabilidad de Mayo-Portland (MPAI) (Malec y Lezac, 2004)

Evalúa las secuelas de los DCA durante la etapa posaguda.

La versión de 2004 (MPAI-4) se organiza en tres subescalas (capacidad, ajuste y participación). Miden el estado actual del paciente con lesión cerebral (cognitivo, conductual, emocional, funcional) y la presencia de otros factores que podrían contribuir al estado actual de la persona.

Unas puntuaciones totales inferiores a 30 indican una buena evolución, de 30 a 40, limitaciones leves, de 40 a 50, limitaciones leves a moderadas, de 50 a 60, dificultades moderadas a graves, y superiores a 60, limitaciones graves.

Puede ser cumplimentado por profesionales, pacientes o familiares.

Escala de evaluación de la discapacidad (Rappaport, Hall, Hopkins, Belleza, y Cope, 1982)

La escala de evaluación de la discapacidad (DRS) se creó para obtener información cuantitativa sobre la progresión de los pacientes con DCA en los siguientes aspectos: alerta y conciencia (del ambiente y de uno mismo), capacidad cognitiva para enfrentarse a los problemas del cuidado personal, grado de dependencia física y adaptabilidad psicosocial, reflejada en la capacidad para realizar un trabajo útil.

La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en cada apartado. A mayor puntuación mayor grado de discapacidad.

La escala se puede cumplimentar mediante observación directa o entrevista.

Escala de resultados de Glasgow (GOS) y escala de resultados de Glasgow ampliada (GOSE)

La escala de resultados de Glasgow fue creada por Jennett y Bond (1975) para complementar a la GCS. Es una escala simple que evalúa el nivel de afectación en los aspectos vitales fundamentales. No detalla déficits específicos, sino que evalúa la calidad de vida de los pacientes.

Clasifica a los pacientes en cinco categorías: muerte, estado vegetativo persistente, incapacidad grave, incapacidad moderada y buena recuperación.

En 1981 se propuso la escala de resultados de Glasgow ampliada.

La prueba consiste en una entrevista estructurada centrada en la capacidad funcional social y personal.